جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شاكر حامد شاكر شلبي

المحافظة : الشرقيه **الحي / المدينة :** العاشر من رمضان **العنوان :** العاشر من رمضان

رقم البطاقة : 27110131300737 **رقم التليفون :** 01145876932 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 13-10-1971 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان القولون

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان القولون

خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6159] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: شاكر حامد شاكر شلبي
National ID: 27110131300737

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of colon cancer for Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

١٤٧٢٩

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



شاكر

حامد شاكر شلبى

مجاوره ٧٥ قطعه ١٦١ ش ١

العاشر من رمضان - الشرقية

١٩٧١/١٠/١٣

٢٧١ ١٠ ١٣ ١٣ ٠٠٧ ٣٧

KG0508658

National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

[[DOCTYPE:ID_BACK]]
National ID – Back





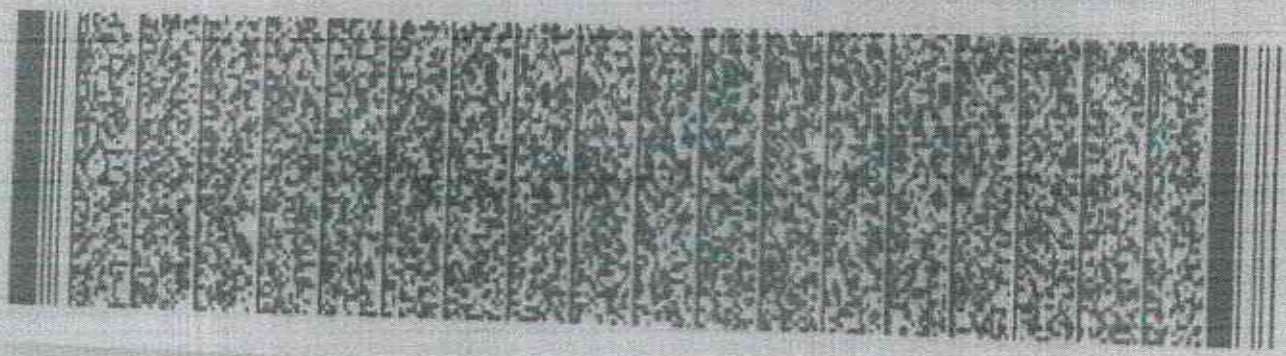
٢٧١١٠١٣١٣٠٠٧٣٧ ٢٠٢٣/١٠

تاجر ادوات صحية وتوريدات

داخل مدينة العاشر من رمضان

ذكر مسلم متزوج

٨ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/١٠/٣٠



Patient Name Shaker Hamed Shaker Shalaby	Patient ID: 1577385
Prof. Dr. Ahmed Yousef El Tnbary	Study Date: 08/10/2026
Acc No: 2972913	

MULTISLICE PELVI-ABDOMINAL TRIPHASIC C.T. SCAN:

Examination performed on our latest generation MDCT machine with ultra thin sections, Injection of non-ionic contrast medium was achieved; dedicated sections were reconstructed, and analyzed on dedicated workstation.

FINDINGS:-



- **The liver is mildly enlarged measures 18 cm in CC diameter with generalized decreased of CT density yet with no focal lesions.**
- No intra or extrahepatic biliary dilatation.
- The portal vein is patent with no thrombosis.
- The spleen is not enlarged, homogenous with no focal lesions.
- Normal CT appearance of the pancreas and both suprarenal glands.
- Both kidneys are functioning and normal.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- **Small sliding hiatus hernia with mild increased gastric mural thickening keeping with gastritis for clinical correlation.**
- Normal appearance of the small bowel and large bowel loops, with no evidence of wall thickening, stricture, pericolonic fat stranding or mass formation.
- The urinary bladder shows normal wall thickness with no stones or masses.
- Normal ischeo-rectal fossae on both sides.
- **The prostate is mildly enlarged indent the bladder base with prostatic concretions noted, sequel of chronic prostatitis.**

- Clear lung bases.
- **The scanned bone window showing scattered sclerotic areas noted at the pelvis and at the T10 body/ pedicle junction, the tiny lesions are keeping with benign bony islands and largest one for clinical, lab correlation and further work up to exclude metastatic nature.**

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name Shaker Hamed Shaker Shalaby	Patient ID: 1577385
Prof. Dr. Ahmed Yousef El Tnbary	Study Date: 08/10/2026
Acc No: 2972913	

IMPRESSION:-

- **Fatty hepatomegaly for clinical and lab correlation.**
- **Small sliding hiatus hernia with mild increased gastric mural thickening keeping with gastritis for clinical correlation.**
- **Sclerotic bony lesion noted at the posterior element of the vertebral body, for further work up to exclude metastatic nature.**

MUCH OBLIGED

DR. Iman Sherif ,MD

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

د / أحمد يوسف الطنباري

أستاذ الجهاز الهضمي والكبد - كلية الطب - جامعة المنصورة
إستشاري مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة
ومناظير القنوات المرارية ومناظير الفراغ الثالث
وأمراض الموجات فوق الصوتية بالمنظار
زميل الكلية الملكية البريطانية للأطباء FRCP
زميل الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي FESGE
زميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي FASGE

GutCare CENTER
DIGESTIVE HEALTHCARE & ENDOSCOPY CENTER
the best CARE your GUT can get

Colonoscopy

Patient name	ID	Age	Sex	Exam date	Referral
شاكر حامد شلبي		54	M	7/10/2026	



ion	Persistent abdominal pain, bleeding per rectum
nt	After obtaining the history and performing the physical examination, the procedure, indications, potential complications were explained to the patient. Patient appeared to understand the benefits and risks of this procedure. Informed consent was obtained from the patient after providing opportunity for questions.
ration	EKG pulse, blood pressure and oxygen saturation monitored
ument	Sonoscape
hesia	Anesthesia Provider
dure	The correct procedure, and the correct equipment in the room were confirmed. The colonoscopy was gently passed through the anal canal into the rectum. The colonoscope was passed to the sigmoid colon. Color, texture, mucosa and anatomy were carefully examined with the scope. The patient tolerated the procedure well and there were no complications. After completion of the examination, patient was transferred to the recovery room.
paration	---
ndrawal time	---
e	Free
dings	**Examination up to the sigmoid colon revealed annular sigmoid mass with ulcerated surface, vulnerable bleeding mucosa and distorted pit pattern not passable with the scope ..... mostly malignant mass .... *multiple biopsies were taken***
	Normal mucosa with normal vascular pattern of the rectum
	Retroflexion of the scope show small internal piles
on	**Malignant sigmoid mass**
	For pathological examination of biopsies

Signature

Prof. Ahmed Altonbary, MD, FRCP, FESGE, FASGE

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]



Prof. **WAGDI ELKASHEF**
Professor Of Pathology
Faculty of Medicine, Mansoura University

وجدى الكاشف
أستاذ ورئيس قسم الأنسجة بكلية الطب
جامعة المنصورة

Name: Age: 54 Y. Sex: Male.

Referred by Prof. Ahmed Attobary Date: 10/10/2026 Code: 2610060

Clinical data: Sigmoid mass. Endoscopic biopsy.

Gross examination:

Specimen consists of small fragments of tissue, totally submitted.

Microscopic examination:

Examination of prepared slides revealed infiltration by malignant tumor tissue. The tumor is formed of malignant epithelial cells that are arranged in acinar formations. Tumor cells show moderate degree of nuclear pleomorphism with scattered mitoses. Nuclei are mostly vesicular with prominent nucleoli.

Diagnosis:

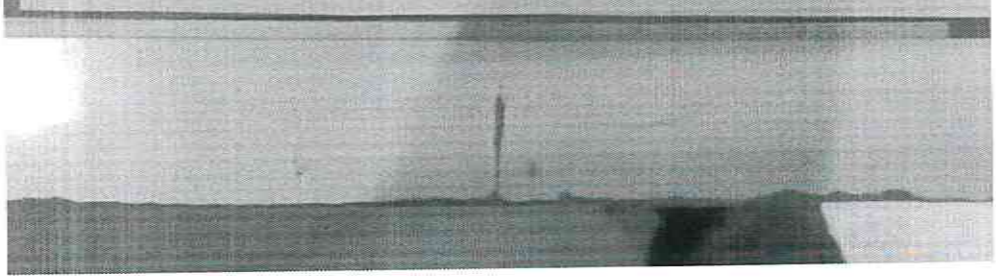
Findings consistent with grade II adenocarcinoma.

Comment: Please correlate with clinical and endoscopic data.

Pathologist

Prof. Wagdi Elkashef, M.D, Ph.D.

010 17 05 08 01 المنصورة من شارع الجيش برج الحجاز الدور السادس
015 50 55 95 64 شارع حيضان برج الدكتور الطبيب العام مركز الجدار المنصورة الدور العاشر



CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

١٤٧٢٩

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



شاكر
حامد شاكر شلبى
مجاوره ٧٥ قطعه ١٦١ ش ١
العاشر من رمضان - الشرقية



١٩٧١/١٠/١٣

٢٧١ ١٠ ١٣ ١٣ ٠٠٧ ٣٧

KG0508658

National ID - Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]

[[DOCTYPE:ID_BACK]]
National ID – Back



٢٧١١٠١٣١٣٠٠٧٣٧ ٢٠٢٣/١٠

تاجر ادوات صحية وتوريدات

داخل مدينة العاشر من رمضان

ذكر مسلم متزوج

٨ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/١٠/٣٠

Patient Name Shaker Hamed Shaker Shalaby	Patient ID: 1577385
Prof. Dr. Ahmed Yousef El Tnbary	Study Date: 08/10/2026
Acc No: 2972913	

MULTISLICE PELVI-ABDOMINAL TRIPHASIC C.T. SCAN:

Examination performed on our latest generation MDCT machine with ultra thin sections, Injection of non-ionic contrast medium was achieved; dedicated sections were reconstructed, and analyzed on dedicated workstation.

FINDINGS:-



- **The liver is mildly enlarged measures 18 cm in CC diameter with generalized decreased of CT density yet with no focal lesions.**
- No intra or extrahepatic biliary dilatation.
- The portal vein is patent with no thrombosis.
- The spleen is not enlarged, homogenous with no focal lesions.
- Normal CT appearance of the pancreas and both suprarenal glands.
- Both kidneys are functioning and normal.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- **Small sliding hiatus hernia with mild increased gastric mural thickening keeping with gastritis for clinical correlation.**
- Normal appearance of the small bowel and large bowel loops, with no evidence of wall thickening, stricture, pericolonic fat stranding or mass formation.
- The urinary bladder shows normal wall thickness with no stones or masses.
- Normal ischeo-rectal fossae on both sides.
- **The prostate is mildly enlarged indent the bladder base with prostatic concretions noted, sequel of chronic prostatitis.**

- Clear lung bases.
- **The scanned bone window showing scattered sclerotic areas noted at the pelvis and at the T10 body/ pedicle junction, the tiny lesions are keeping with benign bony islands and largest one for clinical, lab correlation and further work up to exclude metastatic nature.**

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name Shaker Hamed Shaker Shalaby	Patient ID: 1577385
Prof. Dr. Ahmed Yousef El Tnbary	Study Date: 08/10/2026
Acc No: 2972913	

IMPRESSION:-

- **Fatty hepatomegaly for clinical and lab correlation.**
- **Small sliding hiatus hernia with mild increased gastric mural thickening keeping with gastritis for clinical correlation.**
- **Sclerotic bony lesion noted at the posterior element of the vertebral body, for further work up to exclude metastatic nature.**

MUCH OBLIGED

DR. Iman Sherif ,MD

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]